



FACULDADE
CIÊNCIAS MÉDICAS
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA



Cognição · rastreio · diagnóstico

Saúde do Idoso

Avaliação Neuropsicológica

Da queixa de memória ao diagnóstico sintromico na pessoa idosa

TEMA	Avaliação neuropsicológica no idoso — rastreio e raciocínio diagnóstico
AUTOR	Prof. Dr. Igor Moraes — CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254; Clínica Médica; Cardiologia)
DISCIPLINA	Saúde do Idoso — 9º período
INSTITUIÇÃO	FCMMG — Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
CARGA HORÁRIA	35 minutos (panorâmica)
DATA / VERSÃO	2026 · v1.0

“Doutor, ando esquecendo nomes” — é Alzheimer, é da idade ou é depressão?



Foto ilustrativa - CC BY-SA (Wikimedia)

Sr. J., 74 anos

Aposentado, 4 anos de escolaridade.

Esquece nomes e compromissos há ~1 ano.

Filha: “está mais quieto e desanimado”.

Três perguntas que mudam tudo:



Mudou em relação ao que ele era? (declínio)



Atrapalha a vida diária? (funcionalidade)



Há humor rebaixado junto? (depressão)



A escolaridade pode enganar o teste?

O Sr. J. atravessa toda a aula — a cada etapa você decide.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final, você conduz e interpreta uma avaliação cognitiva no idoso



Justificar

1

quando rastrear e quando pedir avaliação neuropsicológica formal.



Diferenciar

2

normal × CCL × demência e os 3 D (demência, delirium, depressão).



Aplicar

3

MEEM (ajuste por escolaridade), MoCA, relógio, fluência, Mini-Cog; informante.



Mapear

4

os 6 domínios cognitivos (DSM-5) e os testes de cada um.



Integrar

5

achados no diagnóstico sintromico (DSM-5/NIA-AA/ABN) e na conduta.

Alinhamento construtivo: cada objetivo é cobrado por ≥1 questão no quiz.

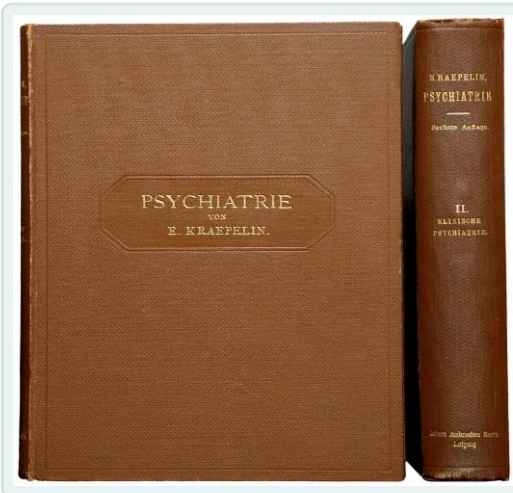
Cinco paradas: do porquê ao diagnóstico e à conduta



O coração da aula é o diferencial: separar envelhecimento normal de doença.

1 • LINHA HISTÓRICA (FONTES PRIMÁRIAS)

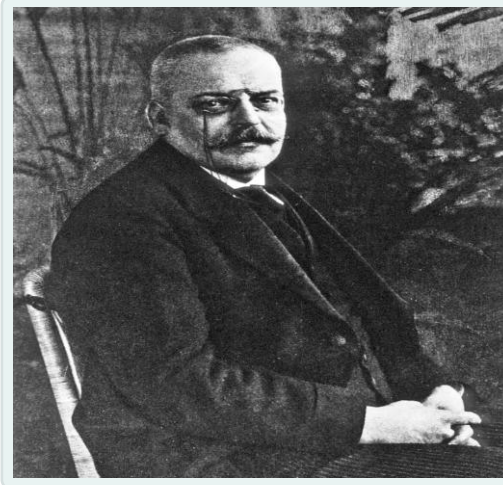
Do tratado de Kraepelin ao caso de Auguste D.: a cognição vira diagnóstico



Kraepelin, Psychiatrie · PD/CC

1899 — Kraepelin

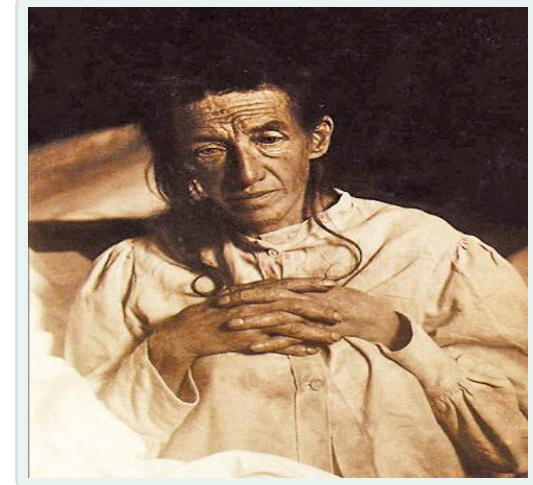
“Psychiatrie”: sistematiza a nosologia psiquiátrica



Alois Alzheimer · domínio público

1906 — Alois Alzheimer

Descreve a doença a partir de um único caso



Auguste D. (1902) · domínio público

Auguste Deter

A 1ª paciente (1901–06): a “realidade” do conceito

Depois vieram os instrumentos de medida: MEEM (1975) → MoCA (2005) → recomendações da ABN.

Demência é frequente no Brasil — e enormemente subdiagnosticada

5,8%

dos idosos (60+) têm demência

~80%

dos casos sem diagnóstico

↑ idade

≈3% (60–65) → >40% (90+)



Foto ilustrativa · CC BY-SA



Por que tantos casos passam batido?

Esquecimento é atribuído à idade; baixa escolaridade dificulta; falta de rastreio na atenção primária. Diagnosticar cedo muda o cuidado — e é papel do clínico, não só do especialista.

Fonte: ELSI-Brasil (Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros).

Rastreio cognitivo ≠ avaliação neuropsicológica formal



Rastreio cognitivo

- Breve (minutos), à beira-leito
- Feito pelo médico/equipe
- Instrumentos: MEEM, MoCA, relógio, Mini-Cog
- Responde: há comprometimento? precisa aprofundar?



Avaliação neuropsicológica formal

- Extensa (horas), testes padronizados
- Feita pelo neuropsicólogo
- Quantifica cada domínio com normas
- Responde: qual o perfil cognitivo? quais domínios?

São complementares: o rastreio levanta a suspeita; a avaliação formal caracteriza o perfil.

4 • INDICAÇÕES

Avalie a cognição diante de queixa, declínio ou mudança — não por rotina cega

Quando rastrear / aprofundar



Queixa do paciente OU do informante



Declínio em relação ao funcionamento prévio



Dificuldade nova em AVD instrumentais



Confusão aguda, quedas, internação, delirium



Polifarmácia / fármacos que afetam cognição

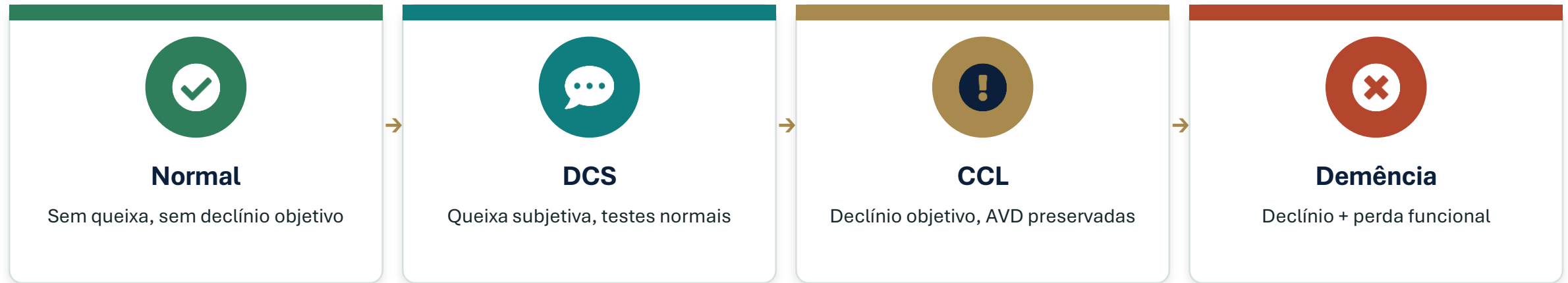


Princípio

A informação do acompanhante é ouro. O idoso pode minimizar (anosognosia) ou supervalorizar (depressão) a queixa.

“Esquecimento que muda a vida” pesa mais que “esquecimento que incomoda”.

Há um contínuo: cognição normal → DCS → CCL → demência



A pergunta que separa CCL de demência: a alteração cognitiva já compromete a independência nas atividades de vida diária? Se NÃO → CCL. Se SIM → demência (transtorno neurocognitivo maior, DSM-5).

O eixo decisivo é a funcionalidade, não só o escore do teste

	Normal	CCL	Demência
Queixa	Possível	Frequente	Presente
Testes cognitivos	Normais	Alterados (leve)	Alterados
AVD instrumentais	Preservadas	Preservadas	Comprometidas
Independência	Total	Mantida	Perdida (progressiva)

Mesmo escore de teste pode ser normal num professor e demência num analfabeto — interprete pela trajetória e pela função.

Antes de dizer “demência”, exclua delirium e depressão



Delirium

- Início AGUDO, curso flutuante
- Atenção prejudicada; nível de consciência altera
- Causa orgânica (infecção, fármaco, metabólico)
- Emergência — reversível se tratado



Depressão

- Humor rebaixado, anedonia
- “Não sei / não tento” (desânimo)
- Memória melhora com pistas
- Tratável → cognição melhora



Demência

- Início INSIDIOSO, progressivo
- Atenção/consciência preservadas no início
- Esquece e não recupera com pistas
- Crônica e progressiva

Coexistem! delirium pode sobrepor demência; depressão e demência andam juntas. Reavalie após tratar o reversível.



Pseudodemência depressiva: a depressão que se veste de demência



Pistas de DEPRESSÃO

- Início mais definido; piora rápida
- Queixa exagerada (“não consigo nada”)
- Respostas “não sei”, baixo esforço
- Memória melhora com pistas/reconhecimento
- Humor rebaixado precede o déficit



Pistas de DEMÊNCIA

- Início insidioso; progressão lenta
- Queixa minimizada (anosognosia)
- Tenta responder; confabula/erra
- Pistas NÃO recuperam a memória
- Déficit precede ou domina o humor

Na dúvida: trate a depressão e reavalie a cognição. Depressão e demência também podem coexistir.

O Sr. J. esquece e está desanimado — qual a melhor primeira hipótese?

Pistas

- Queixa há ~1 ano, progressiva
- Filha nota desânimo e isolamento
- 4 anos de escolaridade
- Sem confusão aguda / sem febre

Conduta inicial mais correta

A

Cravar Alzheimer e iniciar anticolinesterásico

B

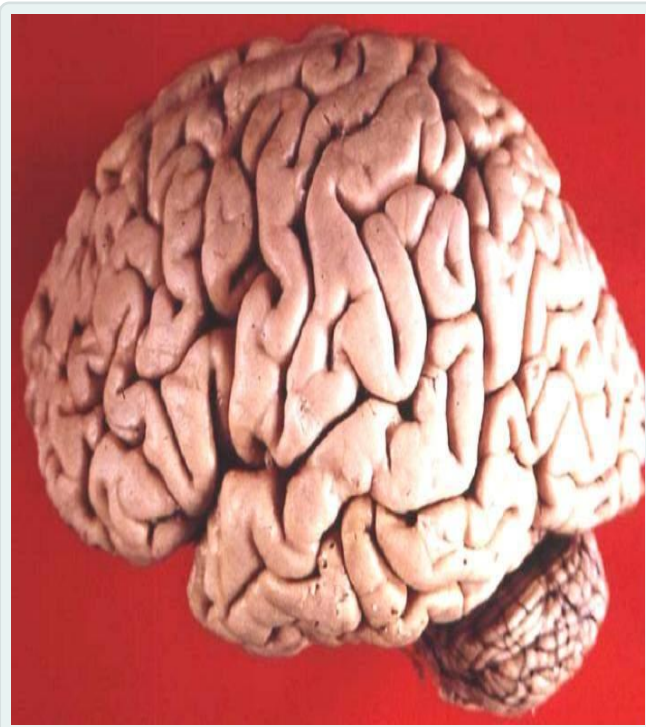
Rastrear cognição (ajustando escolaridade) + avaliar humor/depressão + ouvir a filha

C

Atribuir à idade e reavaliar em 1 ano

Resposta: B — primeiro caracterizar e excluir o reversível (depressão).

A cognição tem 6 domínios (DSM-5) — avalie todos, não só memória



Encéfalo humano · J.A. Beal · CC BY 2.5



Atenção complexa

foco, atenção dividida, velocidade



Função executiva

planejar, inibir, flexibilidade



Aprendizado e memória

episódica, operacional, semântica



Linguagem

nomeação, fluência, compreensão



Perceptomotor

visuoespacial, praxia, construção



Cognição social

reconhecer emoções, comportamento

Fonte: domínios neurocognitivos do DSM-5.

Memória não é uma só: episódica, operacional e semântica



Episódica

Fatos e eventos recentes. A 1ª a cair no Alzheimer.

Teste: evocação de palavras/figuras após intervalo (CERAD)



Operacional

“Segurar e manipular” no agora (memória de trabalho).

Teste: dígitos em ordem inversa; meses ao contrário



Semântica

Conhecimento geral e de palavras.

Teste: nomeação; fluência semântica (animais/min)

Dica: se a evocação melhora MUITO com pistas, pense em disfunção de recuperação (depressão/disexecutivo), não em amnésia hipocampal (Alzheimer).

Função executiva e atenção: onde a vascular e a frontotemporal aparecem



Trail Making (TMT A/B)

alternância, atenção e velocidade



Dígitos (direto/inverso)

amplitude atencional e operacional



Fluência verbal (FAS/animais)

executivo + linguagem



Desenho do relógio

planejamento + visuoespacial



Padrão executivo/atenção predominante (com memória relativamente poupada no início) sugere comprometimento vascular ou frontotemporal — e contrasta com o padrão amnésico do Alzheimer.

Linguagem e habilidades visuoespaciais completam o mapa cognitivo



Linguagem

- Nomeação (Boston) — anomia precoce
- Fluência semântica × fonêmica
- Compreensão e repetição



Visuoespacial / praxia

- Cópia de figuras (pentágonos, cubo)
- Desenho do relógio (também executivo)
- Apraxia: gesto sob comando

Anomia (não achar a palavra) e dificuldade de cópia são sinais úteis e fáceis de checar à beira-leito.

MEEM: o mais usado — mas SEMPRE ajustado à escolaridade



Mini-Exame do Estado Mental

0–30 pontos; orientação, memória, atenção, linguagem, praxia.

Escolar.

NÃO há corte único

+ anos

Corte mais alto

– anos

Corte mais baixo

Alternativas / nuance

Limitação: pouco sensível ao CCL e ao déficit executivo/visuoespacial; sofre forte efeito de escolaridade e idade.



Bandeira clínica

Cravar demência pelo número, ignorando a escolaridade, é o erro nº 1. Use os cortes ajustados (Brucki et al., 2003) e a trajetória.

Fonte: Folstein 1975; normas brasileiras Brucki et al., Arq Neuropsiquiatr 2003.

MoCA: mais sensível ao CCL e ao comprometimento executivo



Montreal Cognitive Assessment

0–30; avalia melhor executivo, atenção e visuoespacial.

≥ 26

Frequentemente normal

< 26

Sugere comprometimento

+1 pt

Se ≤ 12 anos de estudo

Alternativas / nuance

Bom para: detectar CCL e perfis disexecutivos; útil em alta escolaridade (efeito teto do MEEM).



Bandeira clínica

Também sofre escolaridade. Soma-se 1 ponto se ≤12 anos; conferir normas/validação brasileira antes de cravar corte.

Fonte: Nasreddine et al. 2005; conferir validação brasileira (cortes locais).

Três testes de minutos que somam muito ao rastreio



Desenho do relógio

Planejamento + visuoespacial. Rápido e sensível; alterado cedo em várias demências.



Fluência verbal

Animais/min (semântica) ou FAS (fonêmica).
Baixa = executivo/linguagem.



Mini-Cog

Evocação de 3 palavras + relógio. Triagem ultrarrápida na primária.

Combine, não dependa de um só. Um teste rápido alterado indica aprofundar — não fecha diagnóstico sozinho.

O acompanhante vê o que o teste não mostra: use o informante



IQCODE / história colateral

- Compara o desempenho de HOJE com o de 10 anos atrás
- Pouco afetado pela escolaridade do paciente
- Detecta declínio mesmo com teste “no corte”
- Pergunte por exemplos concretos do dia a dia



Perguntas que valem ouro

- “Ele repete perguntas/histórias?”
- “Esquece compromissos, remédios, panela no fogo?”
- “Parou de fazer algo que fazia bem?”
- “Mudou o humor, a iniciativa, o comportamento?”

Bateria de rastreio do Sr. J. — como ler o conjunto?



MEEM 22/30

“baixo” — mas para 4 anos de escolaridade está perto do esperado



Fluência (animais) baixa

sugere componente executivo/recuperação



Relógio levemente alterado

planejamento/visuoespacial



EGD-15 elevada

humor rebaixado relevante

Leitura integrada

Possível CCL + depressão associada. Conduta: tratar a depressão, ajustar fatores, e REAVALIAR a cognição em semanas — antes de rotular demência. Considerar avaliação neuropsicológica formal.

Quando encaminhar para avaliação neuropsicológica formal

Indicações de encaminhar



Dúvida entre normal × CCL × demência



Definir o perfil/domínios (diferencial de demências)



Alta ou muito baixa escolaridade (rastreo limitado)



Casos médico-legais / capacidade



Linha de base para acompanhar evolução



O que o laudo entrega

- Perfil quantitativo por domínio (vs. normas)
- Padrão compatível (amnéstico, disexecutivo, etc.)
- Grau e impacto funcional
- Recomendações e linha de base p/ seguimento

O teste mente quando você esquece o contexto do paciente



Escolaridade

Baixa derruba o escore; alta mascara déficit (efeito teto)



Sensorial

Visão/audição ruins simulam déficit — corrija antes



Idioma/cultura

Itens enviesados; analfabetismo afeta leitura/escrita



Estado momentâneo

Ansiedade, dor, delirium, fármacos, sono ruim



Regra de ouro: o escore é um dado, não o diagnóstico. Interprete sempre com escolaridade, sentidos, humor, contexto — e a trajetória contada pelo informante.

O rastreio levanta a hipótese; o diagnóstico é clínico e sindrômico

Caminho diagnóstico



1. Síndrome: normal × CCL × demência (DSM-5/NIA-AA)



2. Perfil cognitivo (qual domínio domina)



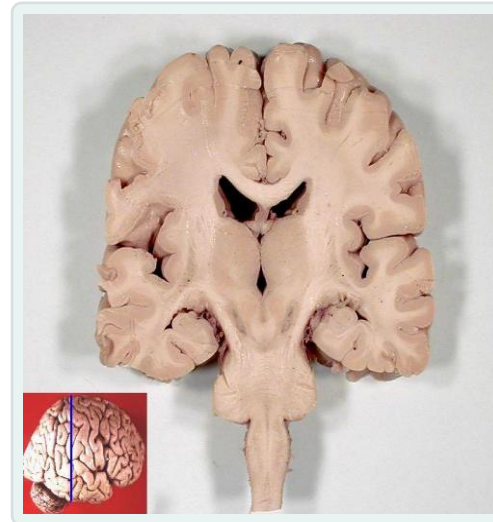
3. Excluir causas 2ª: TSH, B12, Na, função renal/hepática, sífilis/HIV se indicado



4. Neuroimagem (TC/RM) p/ vascular, atrofia, lesões



5. Etiologia (Alzheimer, vascular, FTD, Lewy...)



Encéfalo (corte) - CC BY 2.5



Red flags p/ investigar+

- Início rápido (<6–12m)
- Idade < 65 anos
- Sinais focais/marcha/quedas
- Flutuação, alucinações

Diagnóstico cedo muda o cuidado — mesmo sem cura



No CCL

- Tratar fatores de risco vascular e metabólicos
- Atividade física, sono, social, cognição
- Revisar fármacos (desprescrever o que piora)
- Monitorar: parte evolui, parte estabiliza/reverte



Na demência

- Não farmacológico em 1º plano; metas funcionais
- Plano com cuidador (psicoeducação, segurança)
- Tratar humor/sono/dor; prevenir delirium
- Antidemenciais conforme tipo/estágio; planejar futuro

Conecta com a AGA: cognição é um domínio — integre funcionalidade, humor, fármacos e rede no plano.

O erro nº 1: ler o escore sem ler o paciente



A armadilha

MEEM 22 → “demência”.

Mas o paciente tem 3 anos de escola e está deprimido.

O número sem o contexto cria diagnóstico falso.



Como evitar

- Ajuste à escolaridade; cheque visão/audição
- Exclua delirium e depressão (3 D)
- Ouça o informante; valorize a trajetória



Curiosidade: a doença de Alzheimer nasceu de UM caso — Auguste Deter — descrito por Alzheimer em 1906; a histopatologia que ele desenhou definiu a doença antes de qualquer escala existir.

Leve a régua do diagnóstico cognitivo

Antes de dizer DEMÊNCIA: exclua os **3 D** (Delirium · Depressão · Demência) e os **3 que enganam o teste** (Escolaridade · Sentidos · Ânimo)



Funcionalidade decide

Normal × CCL × demência: o que separa é o impacto nas AVD, não o escore.



Escolaridade sempre

MEEM/MoCA se interpretam por escolaridade; baixa engana. Use o informante.



Rastreio ≠ diagnóstico

O teste levanta hipótese; o diagnóstico é clínico, sintomático e exclui o reversível.

Teste rápido: Q1 a Q3

Q1

Homem, 75a, 3 anos de escola, MEEM 22. Conduta?

A) Demência já definida B) Interpretar pelo corte de escolaridade C) Iniciar donepezila D) Ignorar

Q2

Início agudo, atenção flutuante, após infecção urinária. Diagnóstico mais provável?

A) Alzheimer B) Delirium C) Depressão D) CCL

Q3

Memória ruim que MELHORA com pistas, humor rebaixado, queixa exagerada. Pensar em?

A) Demência avançada B) Pseudodemência depressiva C) Delirium D) Afasia

Pense antes de virar o slide — gabarito comentado a seguir.

Mais três e os comentários

Q4. O que separa CCL de demência?

Q5. Instrumento mais sensível ao CCL/executivo?

Q6. Idoso com queixa: quem dá o dado mais robusto sobre declínio?

Gabarito comentado

Q1 → B — MEEM não tem corte único; 22 com 3 anos de escola pode ser normal.

Q2 → B — Início agudo + atenção flutuante + causa orgânica = delirium.

Q3 → B — Melhora com pistas + humor + queixa exagerada = pseudodemência.

Q4 → AVD — Funcionalidade preservada = CCL; comprometida = demência.

Q5 → MoCA — Mais sensível ao CCL e ao perfil disexecutivo que o MEEM.

Q6 → IQCODE — Informante compara com o passado; pouco afetado por escolaridade.

Recapitule agora — e revise nos próximos dias

Em 30 segundos, recupere de memória:

- A régua: 3 D + 3 que enganam o teste
- O que separa CCL de demência
- 3 instrumentos de rastreio e 1 limitação de cada
- Por que o informante é essencial



3 perguntas para revisar em D+2 e D+7

1. Por que o MEEM precisa de ajuste por escolaridade?
2. Como diferenciar pseudodemência de demência?
3. Quais exames excluem causas reversíveis de declínio?

REFERÊNCIAS (VANCOUVER)

Referências

1. Academia Brasileira de Neurologia (Dep. Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento). Declínio cognitivo subjetivo, comprometimento cognitivo leve e demência — diagnóstico sintromico. Dement Neuropsychol. 2022.
2. ABN. Diagnóstico de doença de Alzheimer no Brasil: avaliação cognitiva e funcional. Arq Neuropsiquiatr / Dement Neuropsychol. 2022.
3. ABN. Diagnóstico do comprometimento cognitivo vascular. Dement Neuropsychol. 2022.
4. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-Mental State”. J Psychiatr Res. 1975;12:189-98.
5. Brucki SMD, Nitrini R, Caramelli P, et al. Sugestões para o uso do Mini-Exame do Estado Mental no Brasil. Arq Neuropsiquiatr. 2003;61:777-81.
6. Nasreddine ZS, et al. The Montreal Cognitive Assessment (MoCA). J Am Geriatr Soc. 2005;53:695-9.
7. American Psychiatric Association. DSM-5 — Transtornos Neurocognitivos. 2013. · McKhann GM, et al. NIA-AA. Alzheimers Dement. 2011.
8. Petersen RC. Mild Cognitive Impairment. N Engl J Med. 2011;364:2227-34.
9. Nitrini R, et al. Bateria Breve de Rastreo Cognitivo / memória de figuras (CERAD-BR). · Sunderland T, et al. Clock drawing. 1989.
10. ELSI-Brasil (Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros) — prevalência de demência. SBGG — avaliação cognitiva na AGA.

Cortes (MEEM/MoCA) dependem de escolaridade — usar normas/validações brasileiras vigentes.

CRÉDITOS

Créditos de imagens e nota de marca

Imagens documentais (domínio público / Wikimedia Commons):

- Retrato de Alois Alzheimer — domínio público
- Auguste Deter (1ª paciente, 1902) — domínio público
- Capa de “Psychiatrie” (E. Kraepelin) — domínio público
- Encéfalo humano (J. A. Beal) — CC BY 2.5

Fotos ilustrativas (Wikimedia, CC BY-SA, com atribuição): idosos no Brasil — Adam Jones; idoso sozinho — jaocampo (CC0). **Ícones:** Font Awesome. **Diagramas:** originais.



Marca institucional: logo oficial da CMMG / FELUMA na capa e banner institucional no encerramento, de uso institucional. Paleta FCMMG.

Obrigado!

Antes de dizer demência: exclua os **3 D** e os 3 que enganam o teste.

Prof. Dr. Igor Moraes · CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254) · Saúde do Idoso — FCMMG

